Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
1ª Vara Cível

Autos nº *0801537-45.2024.8.12.0002*
Parte autora: *Fernanda da Silva Ricarte, Letícia Rodrigues Ricarte, Marcos Ricarte da Silva* e *Perla Loa Rodrigues da Silva*
Parte ré: *Bradesco Saúde S/A.*

Vistos etc.

Perla Loa Rodrigues da Silva, qualificada nos autos, ingressou com a presente demanda de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela em face de *Bradesco Saúde S/A,* também qualificado, aduzindo, em suma, ser contratante de plano de saúde oferecido pela ré, tendo sido diagnosticada com neoplasia de ovário, estando em tratamento clínico e cirúrgico desde outubro de 2018.

Após tratamento médico para tratamento da referida neoplasia, em maio de 2023, seu quadro evoluiu para uma metástase no peritônio, ocasião em que foi prescrito dois ciclos de quimioterapia utilizando-se os protocolos de administração de carboplatina + doxo. lipossomal (sem bevacizumabe), estabilizando-se suas condições clínicas de saúde, para posterior realização de citorredução com quimioterapia hipertérmica intreperitoneal – HIPEC.

Realizado o tratamento quimioterápico, em nova consulta médica em 11 de dezembro de 2023, o cirúrgião oncológico Cézar Augusto Vendas Galhardo atestou a evolução de suas condições clínicas, autorizando-a realizar citorredução com HIPEC prevista em seu protocolo, prescrevendo a referida guia de atendimento.

Submetida a referida guia para autorização, o pleito foi negado sob justificativa de que os requisitos para sua autorização não haviam sido cumpridos, o que é rechaçado pela autora, diante do envio da guia e laudos médicos que atestam a necessidade da submissão ao referido procedimento.

Portanto, ante a negativa de atendimento, ajuizou a presente demanda, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipatória para o fim de obter a autorização da cirurgia de citorredução máxima com uso de quimioterapia hipertérmica intraperitoneal com cisplatina, qual seja, o tratamento com cirurgia Citorredutora associada ao uso de HIPEC (hipertermoquimioterapia intraperitoneal intra-operatoria), a ser realizada por equipe multidisciplinar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.

diretamente no Hospital PRONCOR Geral na cidade de Campo Grande/MS, dentro do programa de Cirurgia Peritoneal e HIPEC, expressamente indicados pela profissional de saúde, inclusive respeitando eventuais alterações na prescrição realizadas pela médica assistente de acordo com as indicações que vierem a surgir, e, quanto o mérito, a confirmação da liminar, bem como a condenação do réu ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Juntou os documentos de fls. 35/529.

Deferida a tutela provisória de urgência às fls. 530/539, determinando-se a citação e a intimação do réu para comparecimento à audiência de conciliação.

O réu foi citado à fl. 548, tendo comparecido à audiência de conciliação, realizada à fl. 595, cujo resultado foi infrutífero.

Em ato contínuo, às fls. 597/608, o réu apresentou defesa, na forma de contestação, defendendo a negativa de atendimento realizada, pois, no primeiro momento, não foi localizada em sistema a solicitação médica para realização do procedimento, orientando a autora a regularizar sua solicitação administrativa, sem êxito.

Ainda, afirmou que o procedimento prescrito não tem indicação clínica para tratamento de neoplasia de ovário, somente para tumores mucinosos do apêndice cecal, do pseudomixoma peritoneal e do mesotelioma peritoneal. Esclarecendo, ainda, que a inclusão do HIPEC para tratamento de neoplasias de ovário ainda encontra-se pendente de autorização pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC.

Diante de tal circunstância, defendeu que o vínculo contratual entre as partes é limitado pelo rol de procedimentos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, diante da constatação de que a prescrição não se correlaciona com o tratamento previsto no referido rol, a negativa de atendimento tem respaldo legal, não se tratando de abuso de direito.

Ao final requereu o julgamento improcedente da pretensão autoral, afastando-se sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
1ª Vara Cível

Juntou os documentos de fls. 609/710.

Informado o falecimento da autora *Perla Loa Rodrigues da Silva* às fls. 723/724 e requerida sua substituição processual por seus herdeiros *Fernanda da Silva Ricarte, Letícia Rodrigues Ricarte, Marcos Ricarte da Silva*.

A substituição processual foi deferida às fls. 743/746, bem como determinada a intimação de *Marcos Ricarte da Silva* para comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Em ato contínuo, sobre a contestação e documentos, manifestaram-se *Fernanda da Silva Ricarte, Letícia Rodrigues Ricarte, Marcos Ricarte da Silva* por meio da petição de fls. 762/775, reiterando-se seus arrazoados.

Indeferida a gratuidade de *Marcos Ricarte da Silva* à fl. 777, bem como determinada a intimação das partes para manifestarem-se sobre as provas que pretendiam produzir.

Em atenção à referida decisão, às fls. 780/781, *Fernanda da Silva Ricarte, Letícia Rodrigues Ricarte, Marcos Ricarte da Silva* requereram o depoimento pessoal do réu, bem como a produção de prova testemunhal e pericial, enquanto que Bradesco Saúde S/A requereu o julgamento antecipado da lide à fl. 782.

À fl. 783 foi indeferida a dilação probatória, determinando-se a intimação das partes quanto ao julgamento antecipado da lide.

Ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação, em decorrência do falecimento da autora *Perla Loa Rodrigues da Silva*, os sucessores *Fernanda da Silva Ricarte, Letícia Rodrigues Ricarte, Marcos Ricarte da Silva* requereram a conversão da obrigação em perdas e danos, correspondente ao valor atualizado dos custos apurados nos orçamentos médicos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Trata-se de demanda de obrigação de fazer proposta inicialmente por *Perla Loa Rodrigues da Silva*, sucedida por *Fernanda da Silva Ricarte, Letícia*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
1ª Vara Cível

Rodrigues Ricarte, Marcos Ricarte da Silva em razão de seu óbito, comprovado à fl. 726 em face de *Bradesco Saúde S/A*, todos qualificadas nos autos.

Embora a parte ré não tenha levantado preliminares, a conversão da obrigação em perdas e danos requerida às fls. 792/795 impede o julgamento do mérito da pretensão autoral.

Em conformidade com o artigo 499 do Código de Processo Civil, *"a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente"*. Todavia, embora o falecimento da autora *Perla Loa Rodrigues da Silva* resulte na impossibilidade do comprimento da tutela específica ou do resultado prático equivalente, a análise quanto a possibilidade da conversão da obrigação em perdas e danos se dá quanto ao prisma/ótica da autora originária e não os seus sucessores.

Tratando-se de lide inerente à obrigação de fazer, embora a obrigação seja de natureza fungível, admitindo-se que qualquer outro sujeito a cumpra, o beneficiário (sujeito ativo) da referida prestação não é, tratando-se de obrigação personalíssima, ou seja, na impossibilidade do sujeito ativo receber o objeto da obrigação, somente ele tem direito às respectivas perdas e danos, não se admitindo sucessão, tampouco sub-rogação aos referidos direitos.

Fredie Didier Júnior afirma que *"a impossibilidade capaz de gerar a conversão da obrigação em prestação pecuniária há de ser (i) superveniente, (ii) absoluta e (iii) imputável ao devedor[1]"* e, embora o caso sob julgamento permita concluir que os fatos são supervenientes e imputáveis ao devedor, em mora porque não descumprida a tutela provisória de urgência de fls. 530/539, a impossibilidade não é absoluta, pois, tratando-se de *"impossibilidade relativa (ou subjetiva) somente gera a conversibilidade quando a obrigação originária tiver caráter infungível, isto é, quando ela tiver que ser cumprida pessoalmente pelo devedor[2]"*, o que não é o caso.

Há que se diferenciar o direito obrigacional da responsabilidade civil dela decorrente, pois a pretensão de fls. 792/795 envolve a reparação civil à família pelo descumprimento da obrigação de fazer em benefício da então autora Perla loa Rodrigues da Silva, o que não é objeto da lide, tampouco autoriza a conversão da referida obrigação em perdas e danos, frente ao caráter personalíssimo mencionado.

---

[1] DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: execução / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira – 8. ed. rev., ampl., e atual., - Salvador: Ed. JusPodivm. 2018. p. 600.
[2] IBIDEM 1. p. 601.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
1ª Vara Cível

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO E IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. REFORMA PARCIAL DO DECISUM. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, CF. SÚMULA 65 TJRJ. ASSUNTO JÁ REITERADAMENTE APRECIADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO, EM SENTIDO AMPLO, DE ASSEGURAR A TODOS OS CIDADÃOS O DIREITO FUNDAMENTAL À PRESERVAÇÃO DA VIDA E SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS HIPOSSUFICIENTES, NOS TERMOS DO ART. 196, CF. LAUDO MÉDICO QUE INDICAVA A NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE GRANDE PORTE, SOB O RISCO DE PIORA DO QUADRO CLÍNICO OU ATÉ MORTE DO AUTOR. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NA REDE PÚBLICA OU, SUBSIDIARIAMENTE, NA REDE PRIVADA ÀS EXPENSAS DOS RÉUS, ORA APELADOS, SOB PENA DE MULTA. TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA O HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU, ONDE PERMANECEU NO CORREDOR DO HOSPITAL. JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A MAJORAÇÃO DA MULTA. DECISÃO QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O AUTOR EFETIVAMENTE TENHA SIDO TRANSFERIDO PARA CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA. ÓBITO DO AUTOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 642 STJ. DANOS MORAIS INCONTESTES NA HIPÓTESE PELO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA DECISÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR, IDOSO, ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE. MULTA COMINATÓRIA QUE DEVE SER APLICADA IN CASU. PEDIDO DE CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS QUE NÃO MERECE PROSPERAR. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA, INTRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
1ª Vara Cível

00125169220208190213 202200148239, Relator: Des(a). MAURO PEREIRA MARTINS, Data de Julgamento: 02/03/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. HOME CARE. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DA LIDE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OBRIGAÇÃO INTRANSMISSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, NA FORMA DO ART. 499 DO CPC. 1. Em que pese julgado procedente o pedido, para determinar que a parte ré fornecesse o atendimento médico domiciliar (home care), houve a modificação da sentença em embargos declaratórios para extinguir o feito sem resolução de mérito, considerando o falecimento da parte. 2. Descabida a conversão da obrigação em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC na espécie, pois, quando da sentença, o objeto da lide já havia sido esvaziado ante o falecimento da parte, não se tratando de obrigação transmissível. 3. A impossibilidade de concessão da tutela específica deve ser aferida enquanto subsistente o objeto, situação inocorrente no caso, em que ao tempo da sentença já havia falecido a parte que necessitava de tratamento médico home care. Distinção feita quanto ao precedente mencionado pela parte apelante (REsp 1.358.726/RJ).NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJ-RS - AC: 70082759937 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 10/10/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019).

Indefiro, portanto, a conversão da lide em perdas e danos.

No mais, o processo reclama deslinde imediato, tendo em vista serem os elementos trazidos aos autos suficientes para a prolação de sentença, daí porque passo ao julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Em análise dos autos, verifica-se ser indevida a negativa apresentada pela *Bradesco Saúde S/A.* no âmbito administrativo e judicial, pois, diversamente do alegado, as provas documentais constantes nos autos são claras quanto ao diagnóstico de metástase no peritônio, circunstância que autorizava a submissão de *Perla Loa Rodrigues da Silva* à cirurgia de citorredução máxima com uso de quimioterapia hipertérmica intraperitoneal com cisplatina – HIPEC, nos moldes prescritos pelo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.

médico assistente, vez que, na época da prescrição médica, o referido procedimento estava previsto rol de procedimentos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, como indicativo para neoplasias no peritôneo, conforme extraí-se do Parecer Técnico n. 38/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021[3] da referida agência regularadora:

> Portanto, a QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA, quando associada a procedimentos citorredutores, para o tratamento dos tumores mucinosos do apêndice cecal / Pseudomyxoma peritonei ou mesotelioma peritoneal, deve ter sua cobertura assegurada pelas operadoras de planos assistência à saúde, estando contemplada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, por meio dos procedimentos:
>
> - TERAPIA ONCOLÓGICA COM APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRACAVITÁRIA OU INTRATECAL, disposto no subgrupo TERAPÊUTICA, grupo PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, capítulo PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, segmentação Hospitalar e Plano Referência, sendo considerado Procedimento de Alto Custo/Alta complexidade para efeitos de cobertura parcial temporária;
> - TERAPIA ONCOLÓGICA MEDICAMENTOSA PEROPERATÓRIA, disposto no subgrupo TERAPÊUTICA, grupo PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, capítulo PROCEDIMENTOS CLÍNICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, segmentação Hospitalar e Plano Referência, sendo considerado Procedimento de Alto Custo/Alta complexidade para efeitos de cobertura parcial temporária.

Ademais, o laudo médico de fls. 128/130, exarado pelo cirurgião oncológico, Dr. Cezar Augusto V. Galhardo, afirma apresentar a paciente indicação

[3]Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2020/parecer_tecnico_no_38_2021_quimioterapia_intraperitoneal_hipertermica.Pdf . Acesso em 17/12/2024 às 13h44.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.

técnica de cirurgia de citorroedução máxima, com uso quimioterapia hipertérmica intraperitoneal com cisplatina, ser o tratamento o melhor disponível para a paciente, bem como inexistir nenhum outro tratamento que trouxesse benefício minimamente similar, frente todo o histórico clínico e terapêutico desde o primeiro diagnóstico de neoplasia de ovário.

Diante deste conteúdo probatório, o tratamento prescrito tornou-se imprescindível e sem qualquer possibilidade de substituição. Logo, os argumentos são inverossímeis, vez que o artigo 10, § 12, da Lei nº. 9.656/1998, alterado pela Lei nº. 14.307/2022, estabelece ser o rol de procedimentos em saúde da ANS meramente exemplificativo, afastando qualquer interpretação judicial que o reputava taxativo.

Com efeito:

> *Art. 10 (...)*
> *§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)*

Estabelece o § 13 do referido dispositivo, ainda, ser devida a cobertura quando, apesar de não previsto no rol da ANS, *"exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais"* (sic).

No caso, o referido tratamento tem eficácia científica comprovada na literatura médica, publicado na New England Journal of Medicine, e, como bem apontou o cirurgião oncológico à fl. 128, *"provavelmente a revista médica de maior prestígio mundial",* de modo que a referida pesquisa concluiu que entre os pacientes com câncer epitelial de ovário, a realização da HIPEC associada à cirurgia de citorredução trouxe maior sobrevida aos pacientes, comparado ao tratamento cirúrgico sem a associação da HIPEC[4].

[4] Disponível em https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1708618 . Acesso em 17 de dezembro de 2024, às 14h21.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.

Ainda que assim não fosse, o que se admite por epítrope, é entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça caber ao médico assistente indicar qual o melhor tratamento para o paciente, sendo indevida a negativa do plano de saúde.

Neste sentido:

A recusa da operadora do plano de saúde em custear medicamento registrado pela ANVISA e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, ainda que se trate de fármaco off-label ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. (STJ. 4ª Turma.AgInt no AREsp 1.964.268-DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/6/2023) (Info 782).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DE QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA (HIPEC). PACIENTE COM CÂNCER DE OVÁRIO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ANÁLISE DO CASO ATRAVÉS DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. PARECER DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. EFICIÊNCIA RECONHECIDA. FUNDAMENTO DA NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - No feito em deslinde, de acordo com o Relatório Médico de fl. 38, subscrito pelo cirurgião oncológico quer acompanha a Paciente, Dr. Renato Mazon (CRM-CE 7557), a senhora Elena de Castro Maia Ribeiro, nascida em 27/04/1959, "é portadora de adenocarcinoma de ovário EC IIIC, submetida à laparoscopia diagnóstica/laparotomia exploradora com biópsias em setembro de 2018 e seguido de quimioterapia sistêmica com carboplatina + paclitaxel (3 ciclos), com boa resposta, porém ainda com doença residual macroscópica" (sic) - Em razão do quadro clínico da então Promovente, o profissional referido prescreveu a realização de "quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) com cisplatina, associada à cirurgia citorredutora de intervalo" (sic). Ainda segundo o especialista mencionado, "por se tratar de um tratamento sequencial, o ideal é que o procedimento seja realizado até seis semanas após a data do término da quimioterapia neoadjuvante (04/12/18), pois a após este período o benefício da quimioterapia neoadjuvante e resultado oncológico começam a diminuir, dado o risco de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
1ª Vara Cível

recidiva precoce por falta de tratamento" (sic) - Ressaltou também o médico suso exposto, no Relatório Médico de fls. 46/49, que: "Por se tratar de doença peritoneal extensa, com grandes chances de recidiva local após tratamento convencional, trabalhos de impacto tem mostrado que o uso da quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) com cisplatina, associada à cirurgia citorredutora de intervalo tem mostrado benefícios concretos, com ganho de sobrevida global e livre de doença quando comparado à cirurgia apenas. Ou seja, pacientes submetidas a tratamento com HIPEC associado à cirurgia e quimioterapia sistêmica tem sobrevivido mais e sem doença quando comparadas a pacientes sem o tratamento com HIPEC.Em resumo, baseado em evidências científicas (em anexo), proponho como melhor terapia para a paciente citada a realização de cirurgia citorredutora com ressecção multivisceral seguido de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) transoperatória e posterior quimioterapia sistêmica"(sic) - Apesar disto, a GEAP – Autogestão em Saúde, contrapondo-se ao procedimento fundamentadamente indicado à Paciente, negou a sua realização, sob o argumento de que este não se encontra previsto no rol de procedimentos da ANS e, portanto, não tem cobertura contratual (fl. 43) - No entanto, de acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato de determinado recurso terapêutico não constar na lista da ANS não significa, per si, que não possa ser exigido pelo usuário, porquanto aludido expediente se trata de rol exemplificativo (AgInt no REsp 1897025/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) - Neste ponto, impende frisar que, embora exista um conflito entre as Turmas do STJ acerca da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, nenhum dos dois posicionamentos detém força vinculante, de forma que é legítimo adotar o entendimento dominante nesta 1ª Câmara de Direito Privado, no sentido de que o aludido ato é meramente exemplificativo. - E, sob este prisma, considero que é nula de pleno direito a cláusula contratual que exclui da cobertura o tratamento vindicado, porque, a rigor, finda por exaurir, na essência, a consecução do objetivo do convênio, que é a preservação da saúde da associada - Por certo, não é admissível a exclusão ou limitação de recurso terapêutico sem a expressa previsão legal, notadamente porque, caso contrário, não só estar-se-ia limitando a atuação dos médicos às indicações de natureza administrativa da ANS, cujo rol é exemplificativo, como obstaculizando o acesso dos beneficiários da Operadora do Plano de Saúde aos procedimentos criados com os avanços da medicina e recomendados pelos profissionais especialistas - Outrossim, a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.

pretensa exclusão do custeio do tratamento vindicado somente poderia ser acolhida se houvesse manifesto descompasso entre a enfermidade e a sua proposta, ante a relevância da avaliação do caso concreto com base na corrente da Medicina Baseada em Evidências, sendo forçoso analisar a questão sob os parâmetros da eficácia e da segurança - Neste ponto, frise-se que restou evidente, conforme o Parecer nº 06/2017, emitido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que o tratamento com 'quimioterapia hipertérmica intraperitoneal' associado à cirurgia de 'citorredução' nos casos de comprometimento peritoneal, como na hipótese em tela, tem melhores resultados quanto ao tempo de sobrevida livre de doença e tempo médio de sobrevida, quando comparado com o tratamento quimioterápico sistêmico, sendo portanto, eficaz - Ademais, verifica-se que a Apelada já havia sido submetida aos tratamentos convencionais, sem contudo, obter êxito, de modo que a adequação e a necessidade do recurso terapêutico indicado para a doença que acomete a Recorrida restam caracterizadas. E, quanto à segurança do procedimento, notadamente no que diz respeito aos riscos envolvidos, não vislumbro que estes sejam superiores ao elevado risco de morte decorrente da própria enfermidade da então Autora, podendo, portanto, tal questão ser relativizada - Desta forma, considerando o contexto acima mencionado, em especial, a recomendação médica incisiva do tratamento para a melhora do quadro de saúde da então Demandante, assim como os princípios da boa-fé contratual, da transparência e da informação, deve sim a GEAP – Autogestão em Saúde custear o procedimento requerido - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 0101109-51.2019.8.06.0001, acorda a 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 11 de agosto de 2021. VERA LÚCIA CORREIA LIMA Desembargadora Relatora. (TJ-CE - AC: 01011095120198060001 CE 0101109-51.2019.8.06.0001, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 11/08/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2021).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA (HIPEC). PACIENTE COM CÂNCER DE OVÁRIO. PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
1ª Vara Cível

CARÁTER EMERGENCIAL COMPROVADO. ANÁLISE DO CASO ATRAVÉS DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIA. PARECER DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. EFICIÊNCIA RECONHECIDA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O cerne da controvérsia consiste na possibilidade de deferimento do custeio, pelo Plano de Saúde, de tratamento consistente em 'quimioterapia interperitoneal hipertérmica (HIPEC) associada a cirurgia citorredutora de intervalo', conforme prescrição médica, por ter sido a paciente diagnosticada com câncer ('andenocarcinoma de ovário EC IIIC'), assim como na verificação dos requisitos para a concessão de tal medida de urgência. Inicialmente, cumpre asseverar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde de autogestão, como no presente caso, de acordo com o que enuncia a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a inaplicabilidade da legislação consumerista não é suficiente para autorizar qualquer limitação ou exclusão contratual nos planos de autogestão, na medida em que a operadora de saúde deve observar os princípios da função social do contrato e da boa-fé contratual, nos termos dos arts. 423 e 424 do Código Civil. É certo que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o plano de saúde pode restringir a cobertura contratual a determinadas doenças, mas, uma vez assumido o compromisso de prestação de assistência às moléstias eleitas, não se afigura lícito impor limitações referentes aos procedimentos necessários para tratamento ou recuperação da saúde dos pacientes, porquanto é atribuição do médico especialista, com o consentimento do enfermo, a escolha da melhor forma de tratar a patologia. Sabe-se, ainda, que o tratamento prescrito não se encontra previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), mas há de se considerar o fato de que não é possível um catálogo de natureza administrativa manter-se constantemente atualizado e contemplar todos os avanços da ciência, muito menos esgotar todas as moléstias e seus meios curativos usados com base científica, sendo, portanto, um rol exemplificativo. A pretensa exclusão do custeio deste tratamento somente poderia ser acolhida se houvesse manifesto descompasso entre a enfermidade e a sua proposta. É que, nos casos que envolvem direito à saúde, a comprovação da moléstia e a necessidade do procedimento não são suficientes para comprovar a verossimilhança do direito alegado, sendo relevante a avaliação do caso concreto com base na corrente da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.

Medicina Baseada em Evidências. É, pois, forçoso analisar a questão sob os parâmetros da eficácia e da segurança. Restou evidente, conforme o Parecer nº 06/2017, emitido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que o tratamento com 'quimioterapia hipertérmica intraperitoneal' associado à cirurgia de 'citorredução' tem melhores resultados quanto ao tempo de sobrevida livre de doença e tempo médio de sobrevida, quando comparado com o tratamento quimioterápico sistêmico, sendo portanto, eficaz. No presente caso, restam claramente configurados os requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, quais sejam, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para a paciente, caso não seja imediatamente submetida ao tratamento para sua patologia, a qual é grave e põe risco à sua vida, e a probabilidade do seu direito, demonstrada pela documentação médica que acompanhou a inicial. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de nº 0620942-98.2019.8.06.0000/50000, acorda a 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 28 de agosto de 2019. DESEMBARGADORA VERA LÚCIA CORREIA LIMA Relatora. (TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0620942-98.2019.8.06.0000 Fortaleza, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 28/08/2019, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFICIÁRIA ACOMETIDA DE CÂNCER DE OVÁRIO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA CITORREDUTORA ASSOCIADA À QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA. RECURSO DA PARTE RÉ. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXEGESE DO ART. 300 DO CPC. MOLÉSTIA CAPAZ DE OCASIONAR GRAVES DANOS À SAÚDE DA ACOMETIDA. NEGATIVA AMPARADA NA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA NO ROL DA ANS. TESE REJEITADA. DEMONSTRADO QUE A HIPÓTESE SE ENQUADRA EM EXCEÇÃO À TAXATIVIDADE DO ROL COM AMPARO NA LEI N. 14.454/2022, PROMULGADA APÓS O JULGAMENTO DO ERESP N. 1886929/SP PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.

E NÃO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5065569-48.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 02-03-2023). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5065569-48.2022.8.24.0000, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 02/03/2023, Segunda Câmara de Direito Civil).

Assim, o acolhimento da pretensão é medida que se impõe.

Assim, tendo a parte ré agido ilicitamente, além da necessidade de ser condenada ao fornecimento do tratamento médico prescrito à parte autora, deve ser condenada em danos morais, conforme determina o artigo 186 do Código Civil c/c artigo 6º, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

No que tange ao montante indenizatório, tenho por bem estabelecê-lo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme pleiteado pela parte autora na petição inicial, tendo em vista a conduta da ré ter-lhe causado dano à sua vida, retardando o início do tratamento prescrito, não trazendo qualquer justificativa plausível à espera entre a prescrição (fl. 128) e a autorização do procedimento, que só foi concedida após o deferimento da tutela provisória de urgência de fls. 530/539, não surtindo, todavia, os efeitos desejados frente ao precoce falecimento, evento que, talvez, pudesse ter sido evitado não houvesse recalcitrância defensiva em cumprir com suas obrigações contratuais.

Ora, o montante acima, além de indenizar a parte autora pela conduta ilícita da ré, serve para o fim de desestimulá-la a continuar com a prática de atos deste jaez, onde coloca em risco a saúde física e psicológica dos consumidores, causando imensa angústia no momento em que se encontram fragilizados pela doença que os

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.

acomete, fazendo com que tenham de buscar o Poder Judiciário para sanar os atos ilícitos praticados, em tormentosa caminhada, regada de incerteza, desalento e frustração, tudo isso enquanto luta pela vida.

No presente caso, a situação se torna ainda mais aflitiva, pois a autora apresentou todos os documentos necessários para o deferimento do tratamento prescrito e ainda viveu a angústia e a expectativa da realização do tratamento prescrito por longos 4 (quatro) meses e, pode-se inferir, morreu (fl. 726) questionando se o resultado não teria sido outro caso autorizado o procedimento logo após a prescrição, não havendo qualquer dúvida acerca do dever de autorizá-lo por parte da ré, que, ao seu turno, não trouxe qualquer justificativa sobre o atraso no atendimento da solicitação do médico assistente, fazendo com que *Perla Loa Rodrigues da Silva* tivesse de enveredar pelos caminhos judiciais, em prejuízo à sua saúde.

Frente ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, *rejeito* a conversão da obrigação em perdas e danos, e quanto ao mérito, *julgo procedente* o pedido formulado por *Fernanda da Silva Ricarte, Letícia Rodrigues Ricarte, Marcos Ricarte da Silva* nos autos deste pedido de obrigação de fazer proposto em face de *Bradesco Saúde S/A*:

a) reconhecer a obrigação de *Bradesco Saúde S/A* em fornecer à então autora *Perla Loa Rodrigues da Silva* a cirurgia de citorredução máxima com uso de quimioterapia hipertérmica intraperitoneal com cisplatina [tratamento com cirurgia Citorredutora associada ao uso de HIPEC, com (hipertermoquimioterapia intraperitoneal intra-operatoria)], expressamente indicados pela profissional de saúde, ficando prejudicada a implementação em decorrência do óbito.

b) condenar *Bradesco Saúde S/A.* ao pagamento em favor de *Fernanda da Silva Ricarte, Letícia Rodrigues Ricarte, Marcos Ricarte da Silva* de indenização por danos morais, estabelecendo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sobre este montante devendo incidir correção monetária pelo IPCA-IBGE a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), além de juros moratórios nos termos do artigo 406, do Código Civil, incidentes a partir da data da citação [(11/03/2024) fl. 548];

c) em razão da sucumbência, condenar a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado pelo IPCA-IBGE a partir da data de distribuição da demanda (22/02/2024), atento ao grau de zelo com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Dourados
1ª Vara Cível

que o/a(s) patrono/a(s) da parte autora lidaram com a demanda, o local de prestação de serviço e o tempo despedindo para tanto, conforme previsto no artigo 85, parágrafo 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil;

d) translade-se cópia da presente ao autos 0001104-74.2024.8.12.0002.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Dourados, 18 de dezembro de 2024.

Alessandro Leite Pereira
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALESSANDRO LEITE PEREIRA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 12:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801537-45.2024.8.12.0002 e código lykd7w2G.